



**INSTRUCTIVO PARA
DILIGENCIAR FORMATOS
DIAGNÓSTICO EN SALUD
PUBLICA PROVINCIAL
SABANA CENTRO
PARA LOS MUNICIPIOS DE
ASOCENTRO**

Consolidado por:

SANDRA LILIANA CORREDOR ESPINEL - Secretaria de Salud Municipio de Cajicá
ALBA MILENA TOVAR LÓPEZ - Profesional Universitario, Secretaría de Salud de Cajicá
LAURA DANIELA GARZON ZAMBRANO
Profesional RIAS – Modelo de Atención, Secretaría de Salud de Cajicá.
Enlace de contacto con los municipios para asesorías personalizadas:

Créditos de elaboración, adaptación y mejora de formatos a:

Erwin Hernández rincón- Coordinador Académico campus virtual OPS- Docente Universidad de la sabana

Luis Jorge Forero García – Auditor de sistema general de Seguridad Tabio y Tenjo

Leidy Julieth Suarez Fernández – Directora de Aseguramiento – Secretaría de Salud de Cajicá

Carlos Fernando Castro Tamayo – MD Epidemiólogo – Secretaría de Salud de Cajicá

Dalis Edit Bello Sastre: - ingeniera de Sistemas – Secretaría de Salud de Cajicá

Alba Milena Tovar López - Profesional Universitario, Secretaría de Salud de Cajicá

Laura Daniela Garzon Zambrano -Profesional RIAS – Modelo de Atención, Secretaría de Salud de Cajicá.

Tabla de contenido

INTRODUCCION.....	3
FORMATOS A DILIGENCIAR.....	4
■ Archivos sueltos en la carpeta general	4
■ CARPETAS ESPECÍFICA DE CADA MUNICIPIO:.....	4
1.INDICADORES SALUD PUBLICA:.....	6
✓ ¿Qué debe hacer?	6
2.RESUMEN_GAUDÍ_2024 aporte del Dr.....	7
✓ ¿Qué debe hacer?	7
✦ ¿Qué debe diligenciar?	7
3.ADHERENCIA_RESOLUCIÓN3280:	8
Beneficios del Formato de Medición.....	8
✓ ¿Qué debe hacer?	8
4.SIAU2024-2025.....	9
5.PLAN_CUIDADO_COMUNITARIO:	10
Objetivos	10
Elementos Clave del Formato	10
Ejemplo de Aplicación.....	10
✓ ¿Qué debe hacer?	11
✦ ¿Qué debe diligenciar?	11
6.MATRIZ_PRIORIZACION	12
Objetivos Específicos	12
Características Clave	12
Aplicación.....	12
✓ ¿Qué debe hacer?	13
7.RISS_2025 (aporte Universidad de la Sábana)	14
Características principales	14
Objetivo	14
Utilidad en el aseguramiento y gestión de servicios	14
✓ ¿Qué debe hacer?	15
? Navegación del archivo: Encontrará un índice interactivo.	15

INTRODUCCION

El presente instructivo tiene como propósito orientar a los equipos técnicos de salud de los municipios que integran ASOCENTRO en el diligenciamiento de los formatos diseñados para la elaboración del diagnóstico situacional en salud. Esta herramienta permitirá consolidar información clave para identificar necesidades, brechas y prioridades en salud pública y en la prestación de servicios, con base en datos demográficos, epidemiológicos, de aseguramiento y percepción comunitaria.

La información recolectada será fundamental para fortalecer la gestión territorial en salud de nuestra región, apoyar la toma de decisiones basadas en evidencia, que responda a las realidades y particularidades de cada municipio.

Este ejercicio técnico y participativo se enmarca en el modelo de redes integradas de servicios de salud, en el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control, y en los principios de equidad, calidad y eficiencia del sistema de salud colombiano.

El instructivo detalla paso a paso cómo diligenciar cada uno de los archivos y pestañas incluidos en la carpeta drive, facilitando un proceso organizado, completo y coherente entre todos los municipios.



Fuente. Imagen tomada de internet

FORMATOS A DILIGENCIAR

Se deben diligenciar 8 formatos de los cuales:

Cinco formatos están en la carpeta general y tres formatos en la carpeta de cada municipio. Los formatos contenidos en la carpeta general, están organizados como libros de Excel y una hoja para ser diligenciada por cada municipio, están formulados para que generen un consolidado provincial.

LOS FORMATOS NO DEBEN SER MODIFICADOS, no aumentar ni quitar filas ni columnas.

LOS FORMATOS NO DEBEN SER MODIFICADOS, no aumentar ni quitar filas ni columnas.

📁 CONTENIDO DE LA CARPETA NOMBRE DE LA CARPETA: **AsocentroSalud2025**

Cada archivo tiene en su interior instrucciones de diligenciamiento. Y se les asigna nombres cortos para que no se pierda la información al ser descargados, comprimidos y extraídos y obedecen a los siguientes archivos:

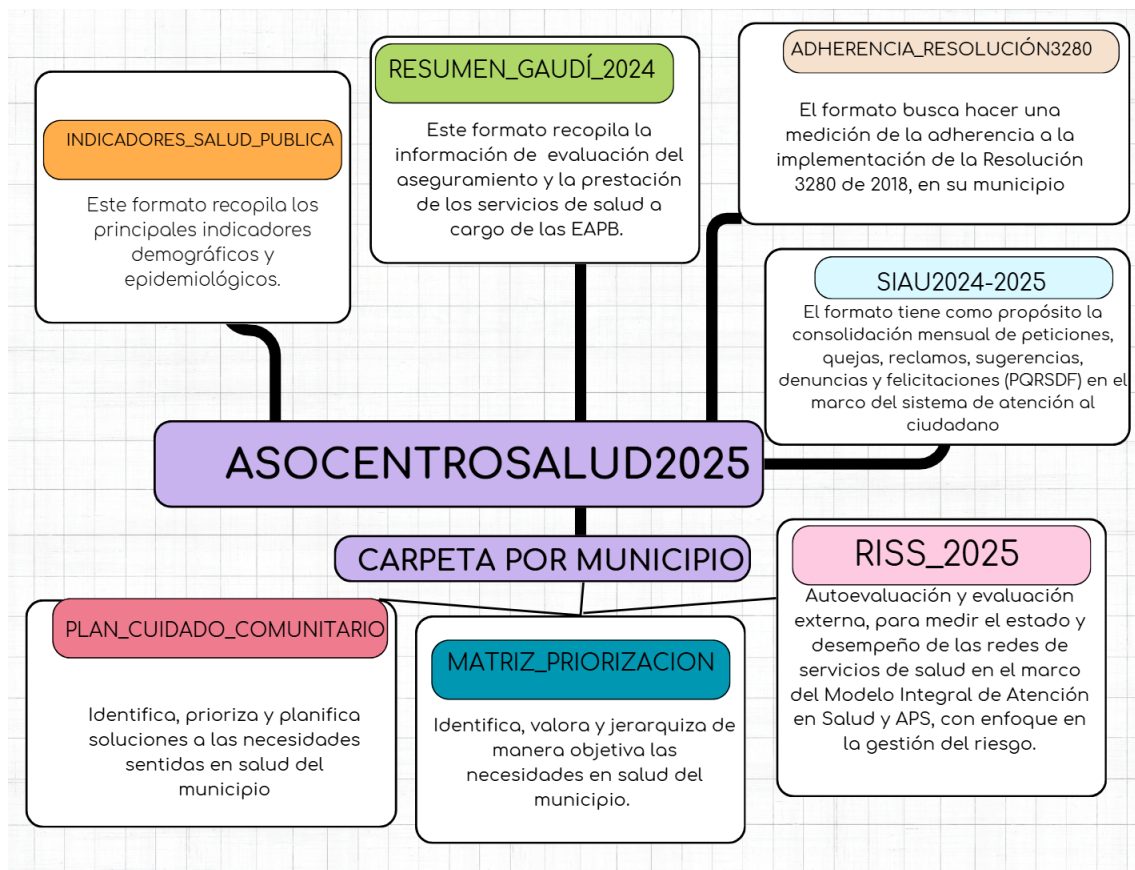
📁 Archivos sueltos en la carpeta general

1. INDICADORES_SALUD_PUBLICA
2. RESUMEN_GAUDÍ_2024
3. ADHERENCIA_RESOLUCIÓN3280
4. SIAU2024-2025

📁 CARPETAS ESPECÍFICA DE CADA MUNICIPIO:

Contiene los siguientes archivos:

5. PLAN_CUIDADO_COMUNITARIO
6. MATRIZ_PRIORIZACION
7. RISS_2025



Fuente: Imagen creación propia.

1.INDICADORES SALUD PUBLICA:

Este formato recopila los principales indicadores demográficos y epidemiológicos que permitirán hacer un análisis de la situación de cada ente territorial, además consolida la información provincial, para facilitar el ejercicio de priorización y plan de acción provincial.

✓ ¿Qué debe hacer?

→ Abrir el archivo INDICADORES_SALUD_PUBLICA.

→ Seleccionar la pestaña correspondiente a su municipio.

★ ¿Qué debe diligenciar?

a. Datos demográficos: Ingrese los valores de todas las variables.

b. Tabla de Indicadores epidemiológicos:

→ Registre los datos en la columna “caso año”.

→ Agregue la fuente de consulta en la última columna correspondiente a cada indicador.



Fuente. Imagen tomada de internet

2.RESUMEN_GAUDÍ_2024 aporte del Dr.

Este formato recopila la información del procedimiento de evaluación del aseguramiento y la prestación de los servicios de salud a cargo de las Entidades Promotoras de Salud (régimen contributivo y subsidiado) que operan en los territorios como responsabilidad de cada uno de los municipios.

✓ ¿Qué debe hacer?

→Abrir el archivo RESUMEN_GAUDÍ_2024

→Seleccionar la pestaña del municipio.

✦ ¿Qué debe diligenciar?

→Registre el número total de afiliados por EAPB por momento de curso de vida.

→Según los criterios asignados, indique si la EAPB “CUMPLE” o “NO CUMPLE”, con corte al año 2024. (Puede consultar: Guía de Auditoría Institucional – GAUDÍ Inspección y Vigilancia a la prestación de servicios y aseguramiento, disponible en la Superintendencia Nacional de Salud).

→ Enseguida, debe describir el hallazgo para cada criterio evaluado.

⚠ Importante: Si su municipio cuenta con más EAPB de las listadas, inclúyase en el campo “Otras EAPB” para que sean evaluadas también.



Fuente. Imagen tomada de internet

3.ADHERENCIA_RESOLUCIÓN3280:

El formato busca hacer una medición de la adherencia a la implementación de la Resolución 3280 de 2018, en su municipio. El formato además de las variables de identificación, tiene dos bloques grandes de medición de adherencia: la medición administrativa (las variables están especificadas) y la medición de prestación de servicios o clínica: Estos porcentajes deben extraerse de los documentos de medición de adherencia que su municipio tenga diseñados (las variables están especificadas).

ADHERENCIA_REOLUCION3280 tiene como objetivos:

- Evaluar y monitorear el grado en que las instituciones de salud y los actores responsables están aplicando los lineamientos técnicos y operativos definidos en la Resolución 3280, que regula las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) para la promoción, mantenimiento y atención materno perinatal.
- Identificar brechas y oportunidades de mejora en la implementación de las acciones y procedimientos establecidos, permitiendo tomar decisiones informadas para garantizar la calidad de la atención y el cumplimiento normativo.
- Asegurar la calidad y la integralidad de la atención en salud, midiendo resultados y verificando que se cumplan los estándares y directrices de obligatorio cumplimiento definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Facilitar la auditoría, seguimiento y control por parte de entidades territoriales, EPS y demás responsables, mediante herramientas como listas de chequeo, informes y planes de mejoramiento, para asegurar la correcta operación de las rutas y el logro de los objetivos en salud pública.

Beneficios del Formato de Medición

- Permite cuantificar la adherencia a la normatividad y detectar áreas críticas.
- Favorece la toma de decisiones basada en evidencia para el fortalecimiento de los servicios de salud.
- Contribuye al mejoramiento continuo en la atención y en los resultados en salud de la población.

✓ ¿Qué debe hacer?

→ Abrir el archivo Formato de medición de adherencia.

→ Diligenciar únicamente las celdas habilitadas, siguiendo las instrucciones contenidas en cada celda del archivo.

⚠ El formato no debe modificarse, debe mantener el número de filas y columnas que tiene para facilitar la consolidación.



Fuente. Imagen tomada de internet

4.SIAU2024-2025

El formato tiene como propósito la consolidación mensual de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones (PQRSDF) en el marco del sistema de atención al ciudadano.

Abra el formulario y diligencie según instrucciones.



Fuente. Imagen tomada de internet

5.PLAN_CUIDADO_COMUNITARIO:

El formato de Plan de Cuidados Comunitarios es una herramienta estructurada diseñada para identificar, priorizar y planificar soluciones a las necesidades sentidas en salud de una comunidad, municipio o territorio. Este formato permite sistematizar la información relevante sobre problemas de salud pública, facilitando la participación comunitaria, la toma de decisiones informada y la gestión integral de intervenciones en salud.

Objetivos

1. Recopilar y organizar información sobre necesidades, causas, consecuencias y poblaciones afectadas en el ámbito local.
2. Guiar el diseño de estrategias y actividades orientadas a la solución de los problemas identificados, siguiendo el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar).
3. Asignar responsabilidades, recursos y plazos claros para la ejecución y seguimiento de las acciones propuestas.
4. Fomentar la corresponsabilidad entre autoridades, comunidad y otros actores, promoviendo la autonomía y la abogacía en salud.

Elementos Clave del Formato

1. Identificación de necesidades: Descripción detallada de los problemas, su afectación y causas.
2. Priorización y planificación: Diseño de estrategias y actividades específicas para abordar cada necesidad.
3. Asignación de responsables: Definición de quiénes lideran y ejecutan cada acción.
4. Cronograma y recursos: Determinación de plazos e insumos necesarios.
5. Enfoque participativo: Integración de la voz de la comunidad y de expertos en salud para garantizar pertinencia y sostenibilidad.

Ejemplo de Aplicación

El formato se utilizó para abordar problemas como accidentes de tránsito en ciclistas, donde se identifican causas, consecuencias y se diseñan estrategias educativas y de comunicación, asignando responsables y estableciendo indicadores de seguimiento.

Este formato es una guía práctica y participativa para transformar las necesidades en salud pública en acciones concretas, promoviendo la equidad, la autonomía comunitaria y el cumplimiento de los derechos y deberes en salud.

Este formato es una guía práctica y participativa para transformar las necesidades en salud pública en acciones concretas, promoviendo la equidad, la autonomía comunitaria y el cumplimiento de los derechos y deberes en salud.

✓ ¿Qué debe hacer?

→ Abrir el archivo PLAN DE CUIDADO COMUNITARIO

→ Utilice los indicadores diligenciados previamente (archivo “formato ____”) y los resultados de análisis con expertos y recabe información de la comunidad mediante ejercicios de priorización participativa.

✦ ¿Qué debe diligenciar?

→ Matriz según las necesidades de salud priorizadas en su municipio.

→ Si hay más de una necesidad con igual nivel de prioridad, puede:

- Copiar la matriz a otra pestaña.
- Elaborar un plan de cuidado comunitario por necesidad.

📎 Apoyo: Se incluye un ejemplo guía para facilitar el diligenciamiento.



Fuente. Imagen tomada de internet

6.MATRIZ_PRIORIZACION

La Matriz de Priorización de Necesidades en Salud Pública es un instrumento metodológico estructurado, diseñado para ser diligenciado colectivamente por un grupo multidisciplinario de expertos en salud pública, con el fin de identificar, valorar y jerarquizar de manera objetiva las necesidades en salud de una comunidad, municipio o territorio.

Este formato permite sistematizar la priorización de problemas de salud pública a través de criterios ponderados como impacto y urgencia, factibilidad, costo-efectividad, alineación con políticas sectoriales y equidad. Cada necesidad identificada es evaluada bajo estos criterios, asignando puntajes que reflejan su relevancia y viabilidad, facilitando así la toma de decisiones basadas en evidencia y contexto local.

Objetivos Específicos

Identificar y priorizar necesidades en salud pública de manera participativa y transparente, integrando el conocimiento técnico, operativo y científico de los expertos involucrados.

Facilitar la planificación estratégica de intervenciones, orientando la asignación de recursos hacia las necesidades más apremiantes y de mayor impacto.

Promover la equidad y la alineación con las prioridades nacionales y locales, asegurando que las soluciones propuestas benefician especialmente a poblaciones vulnerables y respondan a los lineamientos de política pública.

Fomentar la corresponsabilidad y la toma de decisiones colegiada, evitando la subjetividad individual y garantizando la legitimidad y pertinencia de las prioridades seleccionadas.

Características Clave

Participación interdisciplinaria: El formato debe ser diligenciado en reunión de expertos, garantizando la inclusión de diversas perspectivas profesionales.

Criterios objetivos y ponderados: Impacto y urgencia (35%), factibilidad (20%), costo-efectividad (20%), alineación (15%) y equidad (10%), sumando un total de 100 puntos.

Transparencia y trazabilidad: El proceso y los resultados quedan documentados, permitiendo su análisis, seguimiento y auditoría.

Enfoque en la mejora continua: Incluye espacios para análisis de resultados y conclusiones, promoviendo la reflexión y el ajuste de estrategias.

Aplicación

Este formato es fundamental en el ciclo de gestión en salud pública, especialmente en la fase de diagnóstico y priorización, sirviendo como base para la elaboración de planes de cuidados comunitarios, planes de intervención colectiva y políticas locales de salud.

La Matriz de Priorización de Necesidades en Salud Pública es una herramienta esencial para la gestión participativa, transparente y basada en evidencia de las prioridades en salud, asegurando intervenciones más efectivas, equitativas y alineadas con los objetivos de la salud pública contemporánea.

✓ ¿Qué debe hacer?

Abrir el archivo diligenciar las celdas de identificación y seguir las instrucciones allí descritas.



Fuente. Imagen tomada de internet

7.RISS_2025 (aporte Universidad de la Sábana)

El formato de evaluación de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) es un instrumento estructurado de autoevaluación y evaluación externa, diseñado para medir el estado y desempeño de las redes de servicios de salud en el marco del Modelo Integral de Atención en Salud y la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS), con enfoque en la gestión del riesgo y la centralidad en el usuario, su familia y la comunidad.

Este formato permite a los Entes Territoriales identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en la organización, integración, gobernanza, gestión y prestación de los servicios, asegurando la articulación efectiva entre los diferentes niveles de complejidad y actores del sistema.

Características principales

Estructura por dominios: Evalúa dimensiones clave como modelo asistencial, gobernanza y estrategia, organización y gestión, sistemas de asignación e incentivos, y ajuste normativo.

Escala de desempeño: Utiliza una escala objetiva (bajo, regular, aceptable, bueno, excelente) para calificar el nivel de avance en cada aspecto evaluado.

Doble aplicación: Incluye una fase de autoevaluación por parte de los equipos de la subred y una fase de evaluación de pares o externa, garantizando objetividad y transparencia.

Soporte documental: Requiere la sustentación de la información reportada, promoviendo la trazabilidad y la auditoría de los resultados.

Participación multidisciplinaria: Recomendando la intervención de diferentes perfiles profesionales y administrativos para una visión integral.

Objetivo

Evaluar integralmente el estado y desempeño de las RISS, identificando el grado de implementación de los principios de integración, continuidad, calidad, eficiencia y enfoque territorial, para orientar acciones de mejoramiento continuo, fortalecer el aseguramiento y garantizar la atención centrada en las personas.

Utilidad en el aseguramiento y gestión de servicios

Monitoreo y control: Permite a las entidades aseguradoras y gestoras de servicios monitorear el cumplimiento de estándares y la articulación de la red.

Planeación y mejora: Facilita la identificación de brechas y la priorización de intervenciones para fortalecer la red y mejorar los resultados en salud.

Toma de decisiones basada en evidencia: Provee información objetiva y sistematizada para la toma de decisiones estratégicas en la gestión del riesgo y la organización de los servicios.

Rendición de cuentas: Favorece la transparencia y la rendición de cuentas ante los usuarios, las autoridades y los entes de control.

Este formato es una herramienta fundamental para el aseguramiento de la calidad y la integración efectiva de los servicios de salud, alineado con los lineamientos nacionales e internacionales sobre RISS, y orientado a garantizar el acceso, la continuidad y la integralidad de la atención en salud en beneficio de la población.

✓ ¿Qué debe hacer?

- Abrir el archivo V2.1.1 INSTRUCTIVO RISS EN COLOMBIA 1
- Ir a la primera pestaña "Index
- Diligenciar información básica del municipio.

🔗 Navegación del archivo: Encontrará un índice interactivo.

- Haciendo clic sobre cada dominio, podrá ir directamente a cada módulo.
- Lea las instrucciones dentro de cada dominio y diligenciarlos según las indicaciones específicas.



Fuente. Imagen tomada de internet